



認識糖尿病 第二型

控制好血糖，是為了保護眼睛、腎臟、神經與心血管

目標因人而異；請以醫師為您設定的數字為準



掃描看電子版

我的糖化血色素（HbA1c）目標是多少？

與醫師討論後的目標

%

您的情況

HbA1c 目標

為什麼

一般成年人

< 7%

兼顧併發症預防與低血糖風險

年輕、病程短、沒有併發症

可更嚴格 < 6.5%

越早控制好，長期保護越明顯

健康、功能良好的長者

< 7.5%

稍微放寬，避免低血糖

共病多、曾有低血糖、預期餘命有限

放寬，約 8%

避免低血糖比追數字更重要

注意：貧血、地中海型貧血帶原、慢性腎病、洗腎或近期輸血時，HbA1c 可能失真，需搭配其他指標判斷。

要怎麼吃？

沒有「糖尿病專用食物」，重點是總量、種類與時間



全穀根莖
定量不過量



蔬菜佔一半



優質蛋白
魚、豆、蛋



戒含糖飲
影響最大



少精製澱粉
白飯麵包少量



定時定量
不要跳過正餐

以上僅為原則。實際的份量、菜單與外食方式，建議由糖尿病衛教師或營養師依您的個別狀況調整。

藥物與胰島素

用哪一種、用幾種，依血糖、腎功能、心血管狀況與體重由醫師決定

常用的口服與針劑

Metformin 多為第一線

SGLT2 抑制劑、GLP-1 另有心腎保護

腎功能不好時，劑量需調整或換藥

什麼時候會用胰島素

初診斷血糖很高、或口服藥已用足仍未達標

懷孕、嚴重感染、手術或住院期間

肝腎功能不好，許多口服藥受限時

有些是暫時的——不代表病情無效

低血糖怎麼辦？記住「15—15」

冒冷汗、發抖、心悸、飢餓、頭暈、注意力渙散

① 吃 15 公克快速醣類 含糖飲料 120~150 mL | 方糖 3 顆 | 蜂蜜 1 大匙

② 等 15 分鐘再測 沒改善就再吃一次；改善後若離下一餐還久，補充一份點心

不要用巧克力、牛奶、蛋糕（脂肪延緩吸收）；意識不清時不可餵食，立即送醫。開車前先測血糖。

生活上要注意什麼？

血糖以外，血壓、血脂與戒菸同樣影響併發症



每週 150 分鐘
中等強度



自我監測
並記錄下來



每天檢查腳
不赤腳、不自剪



血壓 <130/80
LDL 依風險



戒菸
效益最大



生病時
不可自行停藥

定期篩檢：眼底、腎功能與尿蛋白、足部、血脂每年一次，牙科每半年，並接種流感與肺炎鏈球菌疫苗（詳見電子版）。



出現這些情況，提早回診或立即就醫

反覆低血糖或曾昏迷 | 血糖持續過高合併口渴、多尿、體重下降

想吐、嘔吐、腹痛、呼吸又深又快（可能酮酸中毒） | 腳有傷口、發紅或不癒合

視力突然改變 | 發燒或感染 | 水腫、尿液起泡變多 | 準備懷孕或要手術

胸痛、嚴重喘、單側無力或意識改變 → 立即撥打 119